RECOMENDACIONES TRAZADORAS: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN POBLACIÓN ADULTA

Recomendación 1: Evaluación clínica inicial

Todo paciente con sospecha de infección de vías urinarias deberá contar con un registro completo en la historia clínica de los síntomas urinarios y de los signos de compromiso sistémico que fundamenten el diagnóstico de IVU.

- Durante la valoración inicial deberá documentarse en la historia clínica institucional la presencia o ausencia de síntomas urinarios bajos como disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico y hematuria. De igual forma, se deberá evaluar la presencia de fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, dolor lumbar o dolor a la puño-percusión lumbar, los cuales sugieren compromiso del tracto urinario superior y requieren una evaluación diagnóstica y terapéutica diferente.

Recomendación 2: Identificación y registro de factores de riesgo para infección urinaria complicada

En todos los pacientes con sospecha de infección de vías urinarias deberán registrarse los factores de riesgo que permitan clasificar la infección como complicada y orientar la selección del tratamiento antimicrobiano empírico.

- Durante la evaluación clínica deberán documentarse antecedentes relevantes como:
  - ✓ Instrumentación reciente de la vía urinaria
  - ✓ Uso de catéter urinario
  - ✓ Antecedentes de infección por microorganismos productores de blee
  - ✓ Uso de antimicrobianos durante los últimos tres meses
  - ✓ Enfermedad renal crónica
  - ✓ Inmunosupresión
  - ✓ Litiasis urinaria
  - ✓ Hiperplasia prostática benigna
  - ✓ Anomalías anatómicas del tracto urinario
  - ✓ Hospitalización reciente.

Recomendación 3: Clasificación IVU

Todo paciente con sospecha de infección de vías urinarias deberá ser clasificado y registrado de manera explícita en la historia clínica como una de las siguientes entidades clínicas:

- **IVU complicada**
- **IVU NO complicada**

La clasificación deberá realizarse antes del inicio del tratamiento antimicrobiano y sustentarse en los hallazgos clínicos y paraclínicos disponibles.

Recomendación 4: Solicitud de paraclínicos

- En pacientes con sospecha de IVU no complicada, el diagnóstico puede establecerse principalmente mediante la historia clínica y el examen físico, apoyándose en el uroanálisis cuando exista duda diagnóstica.

- En pacientes con sospecha de pielonefritis o infección urinaria complicada deberán solicitarse estudios complementarios que permitan evaluar el compromiso sistémico, la función renal y la presencia de complicaciones (uroanálisis, urocultivo, hemograma, creatinina sérica y proteína C reactiva)

- En paciente con urosepsis deberán solicitarse: uroanálisis, urocultivo, hemograma, creatinina sérica y proteína C reactiva, hemocultivos, lactato sérico y estudios de imagen

Recomendación 5: Inicio oportuno y selección del tratamiento antimicrobiano empírico

CISTITIS NO COMPLICADA

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
Nitrofurantoína 100 mg	Tableta/ Cápsula **100 mg**	100 mg **VO**	Cada **12 horas**	**5 días**	**PRIMERA LÍNEA** Contraindicada si TFG <45 mL/min o sospecha de pielonefritis.
Cefalexina 500 mg	Cápsula **500 mg**	500 mg **VO**	Cada **6 horas**	**5 días**	**SEGUNDA LÍNEA** institucional.
Fosfomicina trometamol 3 g	Sobre **3 g**	3 g **VO**	Dosis **única**	Dosis **única**	**NO se recomienda su utilización como tratamiento empírico de uso rutinario.** Su uso se restringe como estrategia **PROA** para preservar su eficacia microbiológica y disminuir el riesgo de resistencia bacteriana institucional.

CISTITIS COMPLICADA

MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
Nitrofurantoína	Tableta/Cápsula 100 mg	100 mg VO	Cada 12 horas	5 días	En mujeres posmenopáusicas con TFG ≥45 mL/min y sin sospecha de pielonefritis.
Cefalexina	Cápsula 500 mg	500 mg VO	Cada 6 horas	5 días	Alternativa oral institucional.
Cefazolina	Frasco-ampolla 1 g	1 g IV	Cada 8 horas	Según evolución clínica	Alternativa para pacientes hospitalizados con cistitis complicada.

VIGILADO Supersalud

PIELONEFRITIS/IVU COMPLICADA

ESCENARIO CLÍNICO	MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN
Sin uso de antibióticos en los últimos 3 meses y sin instrumentación urinaria	**Cefazolina**	Frasco-ampolla 1 g	1 g IV	Cada 8 horas	7–10 días
Uso de antibióticos en los últimos 3 meses o antecedente de instrumentación urinaria	**Cefepime**	Frasco-ampolla 2 g	2 g IV	Cada 12 horas*	7–10 días
Alto riesgo de BLEE	**Ertapenem**	Frasco-ampolla 1 g	1 g IV	Cada 24 horas	7–10 días

Recomendación 6: Ajuste del tratamiento según el resultado del urocultivo y antibiograma

Todo paciente con urocultivo y antibiograma disponibles deberá contar con una reevaluación documentada del tratamiento antimicrobiano, registrando la conducta adoptada, ya sea mantener, ajustar, des escalar o suspender el antibiótico, de acuerdo con la evolución clínica y el perfil de susceptibilidad del microorganismo aislado.

Recomendación 7: IVU asociado a catéter

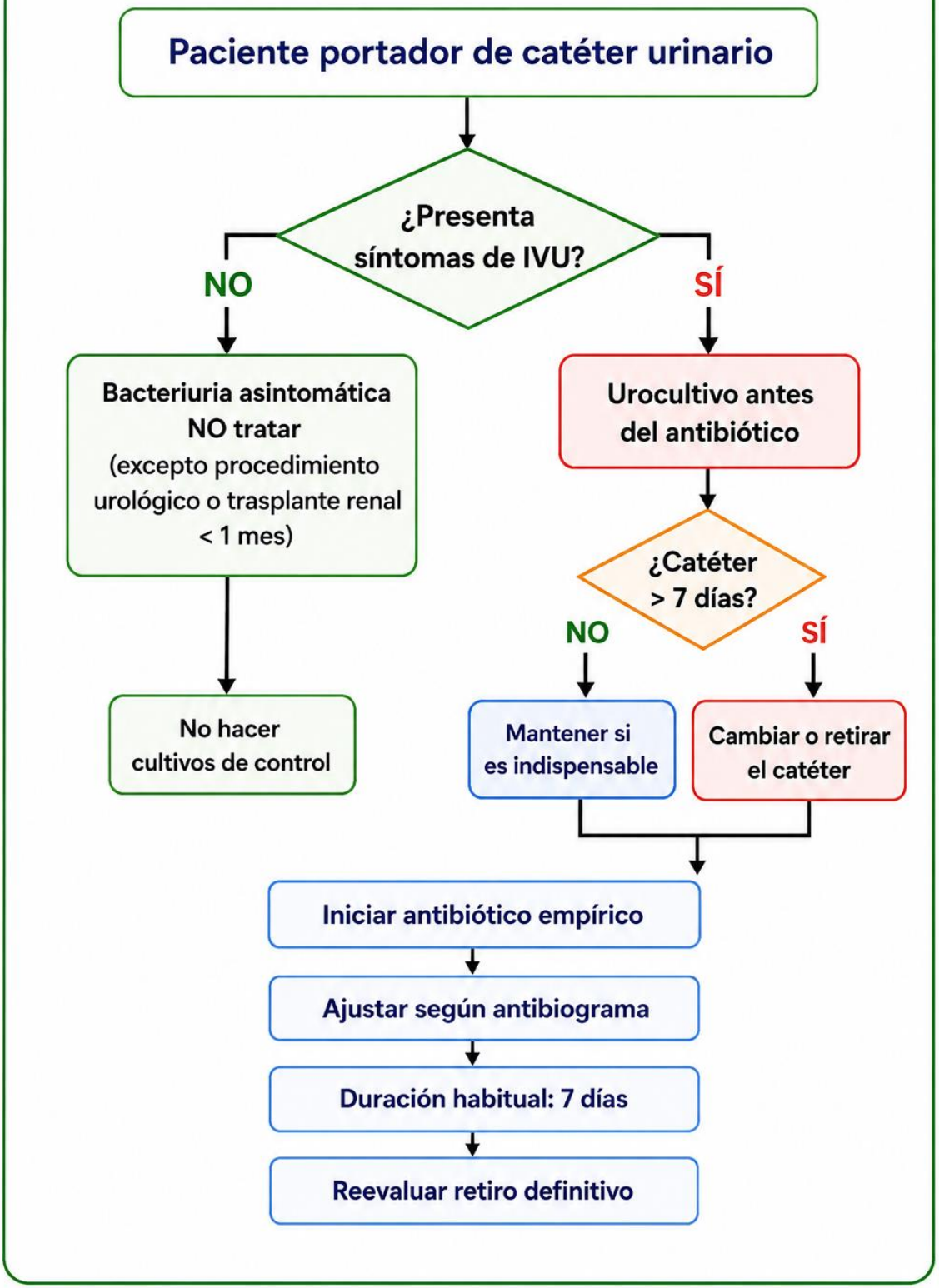
Se recomienda **NO** realizar tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática en pacientes portadores de catéter urinario, salvo indicaciones específicas (procedimiento urológico – paciente con trasplante renal).

- En pacientes con síntomas sugestivos de infección urinaria asociada a catéter, se recomienda tomar urocultivo antes de iniciar antibióticos, retirar o cambiar el catéter si lleva más de 7 días de permanencia (sin retrasar el tratamiento), iniciar antibioticoterapia empírica y ajustarla posteriormente según los resultados del cultivo y antibiograma.

- Revisar el siguiente algoritmo:

VIGILADO Supersalud

ALGORITMO IVU ASOCIADA A CATÉTER



VIGILADO Supersalud